# Guion de la reunión con la Dra. Sara

Reunión por Zoom · 50 minutos. Un día antes, enviarle por WhatsApp la tabla de prioridades (sección 2) para que llegue leída.

**Roles: Pablo** saluda, guía la conversación y hace las preguntas. **William** comparte pantalla con las tablas y el prototipo. **Jack** lee las prioridades de cada módulo. **Fátima** anota las respuestas exactas de la doctora y avisa cuando se acabe el tiempo de cada sección.

Las preguntas con ★ son imprescindibles; si el tiempo no alcanza, hacer solo esas. Los recuadros amarillos indican qué información tenemos que llevarnos de cada parte.

## 1. Saludo · 2 min · Pablo

*«Buenas tardes, doctora. Gracias por su tiempo. Hoy queremos revisar con usted los requerimientos del sistema y su prioridad, mostrarle el prototipo y confirmar algunas reglas y valores. Nos tomará unos 50 minutos. ¿Nos permite grabar la reunión? Es solo para no perder ningún detalle de lo que nos diga y como evidencia del proyecto.»*

**Información que debemos obtener**

- Permiso para grabar (sí o no) y si la grabación queda solo como respaldo interno. No se sube al repositorio público.

## 2. Validar los requerimientos con la técnica MoSCoW · 15 min · Jack lee, Pablo pregunta

*«Con todo lo que nos contó, armamos la lista de lo que debe hacer el sistema y la ordenamos con una técnica que se llama MoSCoW. Cada función queda en uno de cuatro grupos: lo que el sistema debe tener sí o sí, lo que debería tener, lo que podría tener si alcanza el tiempo y lo que no tendrá por ahora. Le vamos a leer cada parte para que nos diga si está de acuerdo o si movería algo de grupo.»*

Compartir la tabla de cada módulo en pantalla. Después de cada respuesta, repetirla en voz alta para confirmarla: «Entonces, esto pasa a debe tener, ¿correcto?», y anotar exactamente lo que ella decida.

**Información que debemos obtener en toda esta sección**

- Si está de acuerdo con el grupo de cada requerimiento, módulo por módulo.
- Qué requerimiento sube o baja de prioridad, y por qué.
- Requerimientos que falten o que sobren.
- Datos concretos (cantidades, horarios, precios, plazos) para completar los criterios de aceptación.

## Módulo 1. Pacientes

| Prioridad | Requerimientos |
|---|---|
| **Debe tener** | Registrar al paciente con sus datos y su seguro · evitar duplicados por cédula · registrar menores con su representante · clasificar como propio o derivado y con plan o por consulta · ficha con la próxima cita primero · historial, mediciones y notas · guardar los PDF de InBody y exámenes · usted y la asistente ven y editan todo. |
| **Debería tener** | Buscar y filtrar pacientes · archivar y reactivar · cargar los pacientes que hoy tiene en Word y Excel. |
| **Podría tener** | Etiquetas y notas libres por paciente. |

**Preguntarle:**

1. ★ ¿Falta algún dato que necesite guardar de cada paciente?
2. ¿Cargar los pacientes que hoy tiene en Word y Excel lo necesita desde el inicio?

**Información que debemos obtener**

- Lista de datos del paciente: cuáles son obligatorios y cuáles opcionales.
- Cómo identificar a pacientes extranjeros sin cédula (pasaporte u otro).
- Si la carga inicial de pacientes sube a «debe tener».

## Módulo 2. Historia clínica

| Prioridad | Requerimientos |
|---|---|
| **Debe tener** | Formulario por enlace en 4 pasos, igual para todos · estado «completa» o «pendiente» en la agenda y en Outlook · consentimiento obligatorio · el paciente no puede editar después de enviar, pero la asistente sí. |
| **Debería tener** | Guardar el avance y seguir después · subir exámenes · un solo recordatorio si no la llena · que usted edite las preguntas. |
| **Podría tener** | Pedirle al paciente que actualice su historia cuando sea necesario. |

**Preguntarle:**

1. ¿Editar las preguntas usted misma lo necesita desde el inicio?
2. Si el paciente no llena la historia, ¿basta con un recordatorio?

**Información que debemos obtener**

- Si los 4 pasos del formulario son correctos y qué preguntas son obligatorias.
- Qué debe decir el consentimiento de datos (ella no tiene un texto).
- Cuántos días antes de la cita se envía el recordatorio de la historia.

## Módulo 3. Citas y agenda

| Prioridad | Requerimientos |
|---|---|
| **Debe tener** | Configurar horarios, duración y feriados · reservar desde el enlace (presencial o virtual, incluso el mismo día) · los pacientes con plan eligen sus 2 fechas del mes · confirmar hasta el día anterior · reprogramar una vez · cancelar hasta 1 día antes sin liberar el horario · que usted o la asistente agenden por el paciente · agenda por semana y en lista · sincronizar con Outlook. |
| **Debería tener** | Máximo 2 citas futuras por paciente · lista de espera · que su agenda personal de Outlook bloquee horarios · bloquear horarios desde la app · enlace de Zoom en la cita · marcar «no asistió» pasados los 15 minutos. |
| **Podría tener** | Mostrar la hora en el país del paciente para las consultas virtuales. |

**Preguntarle:**

1. ★ ¿La lista de espera la necesita desde el inicio?
2. ★ ¿Está bien que se sincronicen con Outlook las citas confirmadas y las pendientes?
3. ¿Los cambios que haga en Outlook deben reflejarse en el sistema?

**Información que debemos obtener**

- Prioridad final de la lista de espera.
- Qué citas van a Outlook y si la sincronización es en un sentido o en ambos.
- Duración de cada tipo de consulta (primera vez, control, caso especial).

## Módulo 4. Mensajes

| Prioridad | Requerimientos |
|---|---|
| **Debe tener** | Bienvenida con la historia clínica al reservar · confirmación 3 días antes · código QR 1 día antes · recordatorios 24 h y 3 h antes · WhatsApp listo para que la asistente lo envíe · correos desde el Gmail del consultorio · nada de mensajes de noche ni en fin de semana. |
| **Debería tener** | Agradecimiento con el InBody después de la consulta · historial de mensajes por paciente · editar los textos de los mensajes · reintentar los correos que fallen. |

**Preguntarle:**

1. ¿El mensaje de agradecimiento con el InBody lo quiere desde la primera versión?
2. ★ ¿Desde qué correo deben salir los mensajes: su Gmail o uno del consultorio?
3. ★ Al inicio nos habló de un mensaje con indicaciones para preparar la bioimpedancia. ¿Se sigue enviando? ¿Cuándo y a qué pacientes?

**Información que debemos obtener**

- Correo desde el que salen los mensajes.
- Si existe el mensaje de preparación para la bioimpedancia, cuándo se envía y su texto.
- Si los momentos de envío (al reservar, 3 días, 1 día, 24 h y 3 h) son correctos.
- Prioridad final del mensaje de agradecimiento.

## Módulo 5. Plan mensual y pagos

| Prioridad | Requerimientos |
|---|---|
| **Debe tener** | Plan de 2 consultas por $70 con el conteo de consultas usadas y perdidas · registrar pagos en efectivo o por transferencia. |
| **Debería tener** | Aviso de plan por renovar · excepciones que usted aprueba · que el paciente vea su plan · avisarle a usted de cada cancelación · informar al médico derivador de cancelaciones o abandonos. |

**Preguntarle:**

1. ¿Avisarle de cada cancelación lo necesita desde el inicio?
2. ★ ¿Hay otro tipo de paquete o precio además del plan de $70?
3. ★ ¿Cuánto tiempo dura el plan desde que se paga?
4. Si un paciente cancela tarde o no asiste, ¿esa consulta del plan se pierde?
5. ¿El plan se paga al reservar la primera cita o en la consulta?

**Información que debemos obtener**

- Tipos de paquete y precios, incluido el precio de la consulta individual.
- Vigencia del plan y momento del pago.
- Qué pasa con la consulta si el paciente cancela tarde o no asiste.
- Quién aprueba las excepciones y cómo se las piden.
- Prioridad final del aviso de cancelaciones.

## Módulo 6. Reportes

| Prioridad | Requerimientos |
|---|---|
| **Debe tener** | Reporte mensual de derivados, uno por cada médico · reporte mensual de pacientes privados · ingresos y pacientes nuevos · descargar en PDF y Excel. |
| **Debería tener** | Filtrar por fechas. |
| **Podría tener** | Enviar el reporte por correo a cada médico derivador. |

**Preguntarle:**

1. ¿Los reportes deben incluir algún dato más?
2. ¿Qué día del mes debe estar listo el reporte para los médicos?

**Información que debemos obtener**

- Columnas exactas de cada reporte.
- Fecha del mes en que se entrega el reporte a los médicos.

### Módulo 7. Seguridad

| Prioridad | Requerimientos |
|---|---|
| **Debe tener** | Ingreso con correo y contraseña, y después con Face ID; sesión de hasta un día · enlaces que vencen a las 72 horas · dar o quitar acceso a la asistente · eliminar los datos de un paciente si lo pide. |
| **Debería tener** | Código de verificación para cambios importantes · cerrar la sesión a distancia si pierde el celular · registro de quién cambió qué. |
| **Podría tener** | Pedir la cédula al abrir el formulario. |

**Preguntarle:**

1. ¿Alguna de estas medidas la necesita desde el inicio?

**Información que debemos obtener**

- Qué medidas de seguridad suben a «debe tener».
- Quién administra las cuentas de usuario (ella o la asistente).

### No lo tendrá por ahora (Won't)

Envío automático por WhatsApp Business · aplicación para pacientes · cobro en línea · facturación del SRI · agenda de la otra doctora.

1. ★ ¿Está de acuerdo con dejar esto para más adelante?

**Información que debemos obtener**

- Confirmación de lo que queda fuera del alcance.

### Funciones que usted mencionó y todavía no están en ningún grupo

Felicitación de cumpleaños · mensajes motivacionales · invitar a volver a los pacientes que dejaron de venir · cuestionario de filtro antes de la primera cita.

1. ★ ¿En qué grupo pondría cada una: debe, debería, podría o no por ahora?

**Información que debemos obtener**

- Prioridad MoSCoW de cada una de las cuatro funciones.

## 3. Mostrar el prototipo · 12 min · William muestra, Pablo pregunta

Compartir pantalla con **pablochacon08.github.io/NutriAgenda**. Antes de empezar, **pegar el enlace en el chat de Zoom** y pedirle que lo abra en su celular, para que ella misma pruebe las pantallas del paciente mientras le explicamos. **Si se conectó al Zoom desde el celular**, no pedirle que abra el enlace: solo mostrar todo en la pantalla compartida.

> *«Ahora le mostramos cómo se vería todo esto. Todavía no es el sistema final: es un prototipo para que vea cómo funcionaría y nos diga qué cambiar. Los datos son inventados y no se guarda nada.»*

**Información que debemos obtener en toda esta sección**

- Por cada pantalla que comente: qué cambiar, quitar o agregar.

- Si ella (como paciente) pudo usarlo sin ayuda y en qué paso dudó.
- Su aprobación del prototipo, con los cambios que pida.

### 3.1 Paciente (lo que ve en su celular desde el enlace)

| Pantalla | Qué hacer | Qué decir |
|---|---|---|
| **Bienvenida** | Abrir «Paciente». Mostrar las políticas del programa. | *«Esto es lo primero que ve un paciente al abrir el enlace que le llega por WhatsApp o correo. No instala nada ni crea cuenta. Aquí lee las políticas: plan de 2 consultas, reprogramar una vez, cancelar 1 día antes y 15 minutos de tolerancia. Con el botón «Aa Letra grande» se agranda el texto, pensado en pacientes con baja visión.»* |
| **Preguntas antes de reservar** | Tocar «Reservar mi cita» y responder las 3 preguntas. | *«Antes de reservar, el paciente responde 3 preguntas cortas: si es su primera consulta, si lo deriva un médico y el motivo. Este es el cuestionario de filtro que usted nos mencionó.»* |
| **Reservar cita** | Dejar que ella elija presencial o virtual, un día y una hora, y toque «Reservar». | *«Los horarios ocupados y los feriados no se pueden elegir. Si no encuentra horario, puede anotarse en la lista de espera. Para reservar debe aceptar recibir los avisos por WhatsApp y correo.»* |
| **Cita reservada** | Mostrar el resumen de la cita y «Lo que viene». | *«Aquí ve su cita y los mensajes que le llegarán: confirmación 3 días antes, código QR 1 día antes y recordatorios 24 y 3 horas antes. Si tiene plan, desde aquí elige la fecha de su segunda consulta.»* |
| **Historia clínica** | Tocar «Llenar mi historia clínica» y avanzar los 4 pasos. | *«El paciente llena su historia en 4 pasos: datos y seguro, antecedentes, alimentación, y exámenes con el consentimiento. Puede seguir después y, si es menor de edad, se piden los datos del representante. Sin aceptar el consentimiento no puede enviar.»* |
| **Mi cita** | Volver y tocar «Ver o cambiar mi cita». Confirmar asistencia. | *«Desde aquí confirma su asistencia, ve el estado de su plan, reprograma una sola vez o cancela.»* |
| **Código QR** | Tocar «Ver mi código QR». | *«Este es el código para ingresar al edificio, que la asistente le envía un día antes.»* |
| **Mensajes que recibe** | Abrir «Mensajes que recibe». | *«Este es el ejemplo de todos los mensajes que recibiría el paciente, en tono formal y cercano, con «usted».»* |
| **Cita cancelada y enlace vencido** | Mostrar rápido las dos pantallas desde la lista de la izquierda. | *«Si cancela, se le avisa a usted y a la asistente. Y si el enlace pasó de 72 horas, ya no funciona, por seguridad.»* |

**Preguntarle:**

1. ★ ¿Pudo reservar sin ayuda desde su celular? ¿En qué paso dudó?

2. ★ ¿Las 3 preguntas antes de reservar son las que usted necesita? ¿Qué pregunta agregaría o quitaría?
3. ¿Tiene pacientes con baja visión o poca costumbre con el celular? ¿Le sirve el botón de letra grande?
4. ¿Le parece fácil para sus pacientes, incluso los adultos mayores?
5. ¿Las políticas que aparecen al inicio son las correctas o falta alguna?
6. ★ ¿Las preguntas de la historia clínica son las que usted necesita? ¿Cuáles deben ser obligatorias?
7. ¿Los mensajes tienen el tono que usted usa con sus pacientes?

**Información que debemos obtener**

- Preguntas finales del cuestionario de filtro.
- Si hace falta más apoyo de accesibilidad (letra, pasos).
- Si las políticas del programa son correctas.
- Cambios en la reserva, la historia clínica y «Mi cita».
- Si el tono de los mensajes es el adecuado.

### 3.2 Doctora (su aplicación en el iPhone)

| Pantalla | Qué hacer | Qué decir |
|---|---|---|
| **Inicio de sesión** | Mostrar el ingreso con correo y el ingreso rápido. | *«La primera vez entra con correo y contraseña; después, con Face ID. La sesión dura hasta un día.»* |
| **Bloqueo por inactividad** | Abrir «Más» › «Seguridad de la sesión». | *«Si no usa la app por 15 minutos, se bloquea y la abre con Face ID. Pasado un día, entra otra vez con correo y contraseña. Son dos tiempos distintos.»* |
| **Agenda** | Mostrar la vista «Lista» y luego «Semana». | *«Al abrir la app ve la agenda del día con el nombre, la hora, si la cita está confirmada y si la historia está completa o pendiente.»* |
| **Detalle de cita** | Tocar la cita de las 14:00. | *«Desde aquí escribe por WhatsApp, llama, abre la ficha, mueve la cita o la marca como atendida o como «no asistió». Abajo ve cómo aparece la cita en Outlook: solo con las iniciales del paciente.»* |
| **Ficha del paciente** | Tocar «Ficha» y recorrer las pestañas. | *«Arriba ve primero la próxima cita, como nos pidió. Luego las mediciones, los PDF de InBody y exámenes, y las notas de cada consulta.»* |
| **Avisos** | Abrir «Avisos» y tocar la solicitud de excepción. | *«Aquí le llegan las nuevas reservas, las cancelaciones y las solicitudes de excepción, que usted aprueba o rechaza. Si Outlook no se sincroniza, también le llega un aviso; el sistema reintenta solo cada 5 minutos.»* |

| Pantalla | Qué hacer | Qué decir |
|---|---|---|
| **Más opciones** | Abrir «Más», luego «Editar formulario» y «Bloquear horario». | *«Aquí cambia las preguntas de la historia clínica sin ayuda técnica y bloquea horarios de su agenda personal, que se reflejan en Outlook.»* |

**Preguntarle:**

1. ★ Al abrir la app, ¿lo primero que quiere ver es la agenda del día?
2. ¿Qué datos quiere ver en cada cita sin tener que abrirla?
3. ★ ¿En la ficha falta algo que usted revise antes de cada consulta?
4. ¿Qué avisos quiere recibir en el celular y cuáles no?
5. Si Outlook no se sincroniza, ¿le basta con el aviso y el reintento automático?

**Información que debemos obtener**

- Qué hacer si falla Outlook (aviso, reintento o ambos).
- Pantalla inicial de la app.
- Datos visibles de cada cita en la agenda.
- Información que falta en la ficha.
- Lista de avisos que quiere recibir.

### 3.3 Asistente (panel web en la computadora)

| Pantalla | Qué hacer | Qué decir |
|---|---|---|
| **Agenda y lista de espera** | Abrir «Asistente». Tocar una cita y la de las 17:15 cancelada. | *«La asistente ve la semana completa, confirma o cancela citas y ofrece el horario cancelado a alguien de la lista de espera. En las citas virtuales copia el enlace de la videollamada, que también va en Outlook y en el recordatorio.»* |
| **Pacientes** | Mostrar el buscador, los filtros y el formulario de registro. | *«Aquí registra pacientes nuevos y busca por nombre o cédula. Puede archivar y reactivar pacientes.»* |
| **Ficha completa** | Tocar un paciente y luego «Ver ficha completa». | *«Aquí ve todo el historial del paciente, edita su historia clínica si hace falta y sube el PDF del InBody.»* |
| **Mensajes y plantillas** | Mostrar los mensajes del día, el historial y las plantillas. | *«Los correos salen solos. Los WhatsApp quedan listos y la asistente los envía con un clic. Aquí también se editan los textos.»* |
| **Paquetes y pagos** | Registrar el pago de María Torres. | *«Aquí se registran los pagos en efectivo o por transferencia, y se ve qué planes están al día o por renovar.»* |
| **Reportes** | Mostrar los reportes de derivados y de privados. | *«Estos son los dos reportes de fin de mes: uno por cada médico derivador y otro de sus pacientes privados, con ingresos y pacientes nuevos, en PDF o Excel.»* |

| Pantalla | Qué hacer | Qué decir |
|---|---|---|
| **Configuración** | Abrir «Configuración» y mostrar Integraciones y Mensajes automáticos. | *«Aquí se elige cómo aparece el paciente en Outlook, la herramienta de las consultas en línea y el tiempo de la sesión. También se prenden o apagan la felicitación de cumpleaños, el mensaje motivacional y la invitación a volver.»* |

**Preguntarle:**

1. ¿Su asistente podría usar este panel sin problema?
2. ¿Los datos del registro de pacientes son los que usted pide hoy?
3. ★ ¿Los reportes tienen la información que piden los médicos derivadores?
4. ★ En Outlook proponemos mostrar solo las iniciales del paciente, porque es un dato de salud y el calendario puede verse en otros dispositivos. ¿Le sirve así?
5. ★ ¿Qué herramienta usa para las consultas en línea: Zoom, Google Meet o videollamada de WhatsApp?
6. ★ Cumpleaños: ¿qué descuento da? Mensaje motivacional: ¿cada 2 semanas está bien? Invitar a volver: ¿después de 3 o de 6 meses sin cita?
7. ¿Qué le cambiaría a cualquiera de las pantallas que vio?

**Información que debemos obtener**

- Cómo aparece el paciente en Outlook.
- Herramienta de las consultas en línea (enlace en el evento de Outlook).
- Descuento de cumpleaños, frecuencia del mensaje motivacional y meses de inactividad.
- Si la asistente podrá usar el panel.
- Campos del registro de pacientes.
- Cambios en los reportes.

## 4. Validar los criterios de calidad · 7 min · William

*«Además de lo que hace el sistema, necesitamos valores para comprobar que funcione bien. Queremos que usted nos diga el valor que le sirve.»*

1. ¿En cuánto tiempo debería poder reservar un paciente una cita, sin ayuda?
2. ¿Cuánto tiempo es razonable que le tome a un paciente llenar la historia clínica?
3. ¿En cuánto tiempo deben aparecer los cambios de citas en su Outlook: al minuto, o le basta en 5 minutos?
4. ★ Si el sistema fallara, ¿cuánta información podría perder sin problema: la de un día o la de una semana? ¿En cuántas horas debería volver a funcionar?
5. ★ ¿En qué horarios no puede fallar el sistema? ¿Cuántas horas al mes de mantenimiento aceptaría, y en qué horario?
6. ★ Si deja la app sin usar, proponemos que se bloquee a los 15 minutos y se abra con Face ID. ¿Le sirve? ¿Y cada cuánto debe volver a ingresar con contraseña: 1 día le parece bien?

7. De cada 200 mensajes automáticos, ¿cuántos podrían fallar sin que sea un problema, si el sistema los reintenta?
8. ¿Cuánto tiempo deben funcionar los enlaces de los pacientes: 72 horas desde que se envían, o hasta un tiempo después de la cita?
9. ¿Cuántas citas atiende como máximo en un día y cuántos pacientes activos tiene?
10. ¿Qué celulares usan sus pacientes (iPhone, Android) y la asistente trabaja en computadora, en celular o en ambos?
11. ¿Qué tamaño tienen normalmente los PDF de InBody y de exámenes?

**Información que debemos obtener**

• El valor que ella fija para cada criterio. Con esos valores se actualizan los requerimientos no funcionales del SRS y se reemplazan los de R1–R8 que ya no coincidan (respaldo, Outlook, enlaces, sesión y disponibilidad).

• Tope de horas de mantenimiento al mes (pendiente de R1).

• Capacidad: citas por día y pacientes activos.

• Dispositivos y navegadores de pacientes y asistente.

## 5. Datos, privacidad y soporte · 4 min · Pablo

*«También necesitamos definir cómo se cuidan los datos de sus pacientes y quién se hará cargo del sistema.»*

1. ★ ¿Cuánto tiempo debe conservar las historias clínicas, por ley o por reglas del hospital?
2. Si un paciente pide borrar sus datos, ¿se borra todo o se guarda la historia clínica el tiempo que exija la ley?
3. Además de usted, ¿alguien más debe autorizar el uso de los datos (el hospital o los médicos derivadores)?
4. ★ Cuando termine el curso, ¿quién administrará el sistema, el alojamiento y la cuenta de correo?
5. ¿Cuánto podría pagar al mes por mantener el sistema funcionando? ¿Acepta que use herramientas gratuitas o de bajo costo y que dependa de Gmail y Outlook?
6. ¿Los pacientes deben aceptar por escrito recibir mensajes por WhatsApp y correo? ¿El Omni Hospital tiene reglas sobre datos de pacientes o sobre el código QR de acceso?
7. ★ ¿Nos podría compartir su formato actual de historia clínica, el Excel de paquetes, un ejemplo de sus mensajes de WhatsApp y un reporte para un médico derivador? (sin datos reales de pacientes)

**Información que debemos obtener**

• Plazo de conservación de las historias clínicas y cómo se combina con la eliminación a pedido (requerimientos legislativos y éticos).

• Responsable del sistema después del curso y presupuesto mensual.

• Reglas del hospital y consentimiento para mensajes (requerimientos externos).

• Sus documentos actuales, para validar los campos, los reportes y el tono de los mensajes.

## 6. Confirmar reglas · 4 min · Pablo

*«Hay algunos puntos que queremos confirmar para hacerlo tal como usted lo necesita.»*

1. ★ Si un recordatorio cae de noche o en fin de semana, ¿se envía antes (por ejemplo, el viernes en la tarde) o no se envía?
2. ★ Cuando un paciente cancela, ¿ese horario se puede ofrecer a alguien de la lista de espera?
3. ¿El paciente puede confirmar desde el mensaje de 3 días antes hasta el día anterior? Si no confirma, ¿la cita se mantiene?
4. ★ ¿La otra doctora también usará el sistema o es solo para usted?
5. ¿Cuántas veces puede reprogramar un paciente la misma cita y con cuánta anticipación?
6. ★ ¿De qué hora a qué hora atiende de lunes a viernes y los sábados?

**Información que debemos obtener**

- Una decisión clara para cada regla; con eso se cierran los asuntos pendientes de la sección 9 del SRS.
- Horario exacto de atención por día.

## 7. Planificar los avances · 3 min · William

*«El próximo semestre construiremos el sistema por partes, con entregas cada dos semanas, y le mostraríamos cada avance.»*

1. ¿Hay alguna fecha en la que necesite que algo ya funcione?
2. ¿Hay épocas en que no estará disponible (viajes o vacaciones)?
3. ¿Le sirve revisar los avances cada dos semanas? ¿En persona, por videollamada o con un enlace en su celular?
4. ★ ¿Podríamos entrevistar 15 minutos a su asistente y enviar una encuesta corta a 5 de sus pacientes?

**Información que debemos obtener**

- Fechas clave y épocas sin disponibilidad, para fijar los hitos del cronograma.
- Frecuencia y forma de revisión de los avances.
- Permiso para entrevistar a la asistente y encuestar a pacientes (evidencia de más técnicas de levantamiento).

## 8. Cierre · 3 min · Pablo y Fátima

*«Para cerrar, le resumimos lo que acordamos: [leer los cambios anotados]. ¿Es correcto?»*

1. ★ ¿Aprueba el prototipo tal como está o con los cambios que nos indicó? ¿Quiere verlo de nuevo antes de la entrega?

**Acta de conformidad:** compartir en pantalla el acta y pedirle que la firme hoy, desde el PDF en su celular o impresa. Un mensaje de WhatsApp no la reemplaza. Si después de esta reunión cambia algo importante del documento, habrá que pedirle una segunda firma.

*«Muchas gracias, doctora. ¿Nos podría firmar el acta de conformidad y escribirnos por WhatsApp un mensaje corto diciendo que aprueba los requerimientos y el prototipo, para dejarlo como constancia? ¿Cuándo le queda bien que nos volvamos a reunir?»*

**Información que debemos obtener**

- Confirmación del resumen de acuerdos.
- Aprobación del prototipo: tal cual o con cambios, y si quiere verlo otra vez.
- Acta de conformidad firmada y aprobación por WhatsApp.
- Fecha de la próxima reunión.